

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	喉癌 Laryngo-Carcinoma				
編號	A31000-Q03-W-K22	制定者	N10 韓蕎伊	公布日期	99 年 01 月 20 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	113 年 09 月 03 日
版本/總頁數	第 3.7 版/10 頁	審查者	曾翊捷	檢閱日期	114 年 08 月 07 日

一、目的

讓護理人員了解喉癌的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與護理措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

喉部(larynx)是位於舌根部(base of tongue)下方至氣管(trachea)上方的解剖構造，其兩側是下咽部梨狀窩(pyriiform sinus)，後方為下咽部後咽壁(posterior pharyngeal wall)，此處長出的腫瘤，經切片診斷為惡性細胞即稱為喉癌。

（二）症狀

聲音沙啞若是持續兩週以上而沒有改善時，應請耳鼻喉科醫師詳細檢查，以期早期診斷及治療。呼吸困難、吞嚥疼痛及困難是腫瘤侵犯食道、舌根或咽喉組織。頸部腫塊是癌細胞向頸部淋巴結轉移所致。咳嗽、痰中帶血是腫瘤組織糜爛發炎、分泌物增加，滯留於氣管及咽喉而產生的。

（三）常見檢查

- 1.間接喉鏡：由醫師將一支帶有長柄的小鏡子伸入嘴中，經由鏡子的反射，可以見喉嚨腫瘤的位置及大小。
- 2.顯微喉鏡：手術室內施行全身麻醉後，再用鑷子夾出可疑的腫瘤部位組織，送病理部門作化驗。

主題名稱	喉癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K22	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	2/10

- 3.軟式鼻咽內視鏡檢查(flexible nasopharyngoscopy)：可以減少吞嚥反射，檢查中可以動態測試發聲、吞嚥和咳嗽等動作，並進行照相或錄影。
- 4.電腦斷層檢查(CT)或磁振造影檢查(MRI)：可用於評估喉部腫瘤侵犯的範圍，是否有甲狀軟骨的破壞，喉外結構的侵犯和頸部淋巴結的轉移。
- 5.正子斷層掃描(PET-CT)：能夠區分惡性腫瘤和其它炎症反應，並可偵測是否有遠處轉移和第二原發惡性腫瘤。

(四) 常見治療

1. 放射線治療

對於第一期和部份第二期喉癌的病人來說是很好的治療方法。放射線治療主要是利用具有穿透力的高能波光子束或粒子射束來治療疾病，這些光束稱為放射線。因為癌細胞的成長及增殖的速度比正常細胞來的快速，高劑量的放射線可以殺死分裂中的細胞或阻止它們的成長及增殖。接受放射線治療的病人可以保存喉嚨的所有功能，所需付出的代價是放射線治療引起的脫皮、噁心、嘔吐及咳嗽等副作用。

2. 手術治療

- (1) 部份喉頭切除：比較晚期的喉癌，若已發生聲帶麻痺和軟骨被侵犯，則採手術治療或再合併放射線治療，仍然可以保留喉頭的功能。
- (2) 全喉切除術：指切除全喉、舌骨、前會厭腔、條狀肌和一個以上的氣管環。使其咽的開口關閉，留置永久性氣管造口，手術後傷口兩側會放引流管約三～四天，待每天的引流量少於 10cc 就可拔掉，但是仍要暫時由鼻胃管灌食 10 天後才可以正常的進食，只是必須由氣管造口處呼吸及咳嗽。

3. 合併治療

對於腫瘤侵犯範圍過大或已有淋巴轉移的病人，合併療法是最好的選擇。合併療法的種類很多，最常用的有下列三種，且此三種合併療法對於較晚期的喉癌病人皆有不錯的治療效果。

- (1) 手術切除加上術後放射線治療。

主題名稱	喉癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K22	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	3/10

(2) 前引性化學治療加上放射線治療或手術。

(3) 合併化學與放射治療。

4. 飲食照護

少量多餐、多攝取高蛋白、高熱量及易消化食品，採冷、涼及質地軟滑食物，避免煙、酒、辛辣或堅硬、粗糙等刺激性食物。

5. 傷口護理

術後依傷口情況，每天為病人更換敷料或塗抹藥膏。定時觀察引流管引流液的性質和量，避免異物掉入氣管造口內。

6. 喉癌病人的復健

手術後由於切除部分或全部的喉嚨，因此術後病人的發聲功能會受到影響，故手術後的最大課題是學習新的發聲方法。無喉者發聲方法的基本原理是創造一種新的發聲源，再將這種聲音導入口腔，而轉化為言語，可將其分為三大類：

(1) 食道發聲法

無喉者的上呼吸道出口，通常是在前頸下方即所謂氣切造口，它與食道是完全分開的。此種發聲法的原理，是指病人將空氣經過舌頭的擠壓而吞入食道和胃裏面，然後再將空氣擠壓出來，此時空氣會使食道和咽部產生振動而發出聲音，病人把這聲音再配合唇及舌的活動就能夠產生話語，成功率在 50% 左右。因不需藉由任何外來器械或手部語言來表達，以及發聲較自然的優點，只要病人的身體狀況允許，且有足夠的學習動機，這是一個優先考慮的方法。

(2) 助講器發聲法

可分為氣動式及電子式助講器。助講器發聲法是無喉者最快，也最容易學會的方法。它能让病人很快得到心理上的補償與安慰。其缺點為音質機械化，不自然，聲音不夠清晰，以及必需手扶助講器。

(3) 氣管食道發聲法

一種簡單易學而且聲音效果最接近正常的方法。成功率可達 70~80%，為

主題名稱	喉癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K22	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	4/10

目前公認最佳的手術性聲音復健法。但必須以手術的方法在食道與氣管間做一瘻管，故常有瘻管阻塞或食物經瘻管流入氣管的問題。

（五）護理問題

1. 口腔黏膜異常／化學治療導致化學性損傷。
2. 口腔黏膜異常／放射線治療導致放射性損傷。
3. 易感染／手術傷口。
4. 缺乏營養／少於身體需要。
5. 語言溝通困難／與聲帶切除有關。
6. 呼吸道清除功能不良／人工呼吸道的留置。
7. 疼痛不適／腫瘤侵犯壓迫下咽部。

（六）護理措施

1. 口腔黏膜異常／化學治療導致化學性損傷
 - (1) 食物應以軟質食物為主，並採少量多餐，且可飲用少量冰涼飲料、果汁或清肉湯等，以緩和口腔及胃部不適。
 - (2) 進食前使用口腔棉籤或軟毛牙刷及含游離氧之抗菌漱口水，執行良好的口腔照護，亦能促進舒適，改善營養狀況。
 - (3) 如有位置不正確的牙齒或假牙，對周圍組織有所摩擦，應速請牙醫師矯正。
 - (4) 口腔清潔後，潰瘍處先以棉棒擦乾，再依醫囑處方使用藥物塗於患部。
 - (5) 進食後，立即清潔口腔。可使用食鹽水漱口（即將1000cc水加9公克食鹽煮開待涼備用），再依醫囑使用漱口水漱口，避免使用含酒精成分的漱口水。
2. 口腔黏膜異常／放射線治療導致放射性損傷
 - (1) 當有口乾舌燥、唾液分泌減少、口腔潰瘍，可使用人工唾液、水及甘油製劑代替唾液來保持黏膜濕潤。
 - (2) 放射線治療部位可能會造成永久性呈黑色或紅銅色，此區域皮膚保持通風及避免日曬。
 - (3) 進食前15～30分鐘依醫囑使用止痛劑。

主題名稱	喉癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K22	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	5/10

(4)刷牙後，可用溫鹽水含漱，達到潤濕口腔的效果。

(5)充分的休息與足夠的睡眠及營養補充，預防感染。

3. 易感染／手術傷口

(1) 監測生命徵象。

(2) 每次換藥時評估、紀錄傷口的變化，內容包括傷口的大小、深度、惡臭及敷料的外觀狀況等，並注意觀察病人對換藥反應。

(3) 依醫囑使用抗生素。

(4) 依醫囑以無菌技術換藥。

(5) 監測全血球計數(CBC)並報告WBC異常現象。

(6) 治療前後洗手。

(7) 教導保持傷口清潔乾燥且避免壓迫傷口。

(8) 教導選擇高蛋白及高維生素飲食，以促進傷口癒合。

4. 缺乏營養／少於身體需要

(1)安排舒適的用餐環境，並鼓勵在用餐半小時前下床活動促進腸蠕動。

(2)鼓勵少量多餐，可多進食高熱量及高蛋白飲食。

(3)會診營養師調配適合病人需求的飲食。

(4)定時測量體重和抽血，以評估病人的營養狀態。

(5)可照會營養師依病人需求來調整飲食內容。

5. 語言溝通困難／與聲帶切除有關

(1)提供紙和筆或可重複使用之磁鐵板讓病人溝通。

(2)接受病人想發聲卻忘了無法發出聲音的挫折感，並利用再保證加強自信心。

(3)提供相關病友使用人工講話器發聲說話的資訊。

(4)以不批評的態度接受病人和家屬的情緒，建立信心培養耐心。

(5)與家屬共同製作溝通輔助用具，列出病人需要用到的片語和語言，以縮短病人溝通的時間。

主題名稱	喉癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K22	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	6/10

(6)床欄放置鈴鐺或報紙，當病人需要協助時，可獲取家屬注意力。

(7)鼓勵利用封閉式問句讓病人表達意見，如：「是」病人可點頭。

6. 呼吸道清除功能不良／人工呼吸道的留置

(1)鼓勵深呼吸，以增加胸內壓利於咳出。

(2)衛教抽痰前先執行10-20分鐘背部扣擊利於痰液咳出。

(3)協助以無菌技術抽吸分泌物，觀察分泌物量和性質。

(4)依醫囑給予化痰藥物使用，以稀釋痰液利於咳出。

(5)每天維持水分攝取約2000～2500cc以上稀釋痰液。

7. 疼痛不適／腫瘤侵犯壓迫下咽部

(1)執行詳細的疼痛評估，包括部位、特性、起始/持續時間、頻率、性質、疼痛強度或嚴重度，以及其他相關因素。

(2)觀察病人不舒適的非語言暗示，特別是無法有效溝通的病人。

(3)確保病人有接受適當之止痛照護。

(4)運用治療性的溝通策略，了解病人的疼痛經驗，並表達對病人疼痛反應的接受。

(5)確認病人的疼痛經驗對其生活品質所造成的衝擊，例如：睡眠、食慾、活動、認知、情緒、人際關係、工作表現及角色責任。

(6)適當地評估病人與疼痛相關之過去經驗，包括慢性疼痛的個人或家族史或疼痛引起之失能。

(7)與病人及健康照護小組共同評估病人過去曾使用過之有效的疼痛控制措施。

(8)協助病人及家屬尋求相關資源及提供心理支持。

(9)提供疼痛相關的資訊，例如：引起疼痛的原因、疼痛持續時間及在某過程中可能出現的不適感。

(10)減少或排除可能引發或增強病人疼痛經驗的因子，例如：害怕、疲乏、單調及認知缺失等。

主題名稱	喉癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K22	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	7/10

- (11) 當選擇疼痛緩解措施時，考慮病人的參與意願、參與能力、喜好、重要親友對此方法的支持，以及禁忌症等。
- (12) 選擇疼痛緩解措施時，須考慮疼痛的型態及位置。
- (13) 鼓勵病人自我監測疼痛的情況，並適度地予以調整。
- (14) 配合醫囑給予止痛藥，以提供病人最理想的疼痛緩解。
- (15) 持續地評估病人的疼痛症狀，以評值疼痛控制措施的成效。
- (16) 促使病人獲得充足的休息睡眠，以協助疼痛的緩減。
- (17) 適當地鼓勵病人討論其疼痛經驗。
- (18) 當使用疼痛緩解方法無效或病人對其疼痛之抱怨不同於往常時，通知醫師做適度的處理。
- (19) 定時監測病人對疼痛處置後的效果。

(七) 衛教指導

- 1.主動提供口腔護理的衛教單張及諮詢。
- 2.教導使用軟毛牙刷和沒有侵蝕性牙膏、避免使用牙線清潔口腔。
- 3.衛教病人口腔黏膜改變的徵象。
- 4.給予飲食衛教採高蛋白、高維生素、高熱量及勿太冷太熱太粗糙之食物。
- 5.教導病人及主要照顧者給予飯後及睡前作口腔清潔。
- 6.選擇不含酒精或刺激性的漱口水。
- 7.教導若有口乾情形時，應攝取足夠的水份或依醫囑給予人工唾液替代。
- 8.教導病人自我照護能力，如:氣切傷口的照護。
- 9.適當穿著有領子衣飾修飾頸部傷口。

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

主題名稱	喉癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K22	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	8/10

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 何念萱、簡珮如、朱本元(2020)•喉癌的臨床症狀與診斷•臨床醫學月刊,86(3),533-539。
[http://dx.doi.org/10.6666/ClinMed.202009_86\(3\).0096](http://dx.doi.org/10.6666/ClinMed.202009_86(3).0096)
- (二) 何念萱、簡珮如、朱本元(2020)•喉癌的治療趨勢•臨床醫學月刊,86(4),609-616。
[http://dx.doi.org/10.6666/ClinMed.202010_86\(4\).0111](http://dx.doi.org/10.6666/ClinMed.202010_86(4).0111)
- (三) 張雅玲、羅玉涵、黃子明、張元玫(2024)•照顧一位下咽癌個案行氣切造口術之護理經驗•秀傳醫學雜誌,23(1),85-95。[https://doi.org/10.30185/SCMJ.202404_23\(1\).0010](https://doi.org/10.30185/SCMJ.202404_23(1).0010)
- (四) Van Sluis, K. E., Van der Molen, L., Van Son, R. J. J. H., Hilgers, F. J. M., Bhairosing, P. A., & Van den Brekel, M. W. M. (2018). Objective and subjective voice outcomes after total laryngectomy: A systematic review. *European Archives of Oto-Rhino-Laryngology*, 275(1), 11-26. <https://doi.org/10.1007/s00405-017-4790-6>

七、附件

(略)

主題名稱	喉癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K22	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	9/10

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
99.01.20	1.0	新制定	99 年 01 月 20 日護理部照護標準委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
100.08.31	2.1	檢視全文並修飾用詞	100 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
101.08.31	2.2	1.檢視全文修正錯字 2.護理部改護理部	101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.08.31	3.1	說明(五)護理問題 7.刪除：疼痛／喉癌 新增：疼痛／腫瘤侵犯壓迫下咽部。	103 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
104.08.31.	3.2	更新第六項參考文獻資料	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
105.08.31	3.3	1. 增修第三項第(六)目之 5 部份內容增修。 2. 新增參考文獻出處於內文中。 3. 更新第六項參考文獻資料。	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
106.08.31	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	3.4	1. 刪除第三項文獻資料：莊等，2013。 2. 第六項參考資料修訂。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過
108.09.23	3.5	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第八日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過；108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。

主題名稱	喉癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K22	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	10/10

修正日期	版本	修正說明	備註
109.08.06	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.10.07	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.11.08	3.6	1. 第三項第一、三、四目內容增修。 2. 更新第三項第五、六目護理問題。 3. 更新第六項參考文獻資料。 4. 內文參考文獻引用刪除	111 年 10 月 06 日照護標準組會議通過； 111 年 10 月 12 日護理長會議通過；111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。
112.08.03	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.09.03	3.7	更新第六項參考文獻資料。	113 年 08 月 08 日照護標準組會議通過； 113 年 08 月 14 日護理長會議通過；113 年 09 月 03 日督導會議通過公布。
114.08.07	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	